Symposium ACM

Prise en charge des allergies chez l'enfant : Quoi de Neuf en 2025?

Pr Fla KOUETA
Pr Titulaire de Pédiatrie
Médecin de Santé Publique et de Santé Communautaire

Plan de présentation

- **INTRODUCTION**

  Epidémiologie et Etiologie

  Mécanismes de la réaction allergique

  Quelques entité cliniques

  Nouveautés diagnostiques

  Quelles approches thérapeutiques

  Messages clés

- **CONCLUSION**

Introduction:
Pourquoi parler des allergies ?

- **Hausse des allergies pédiatriques** : **jusqu'à 40 % des enfants concernés**
- **Impact sur la qualité de vie et la scolarité**
- **Diversité des formes cliniques** : eczéma, rhinite, urticaire, asthme, allergies alimentaires, conjonctivites allergiques,
- **Objectif : mieux diagnostiquer et mieux traiter**

Introduction

Qu’est qu’une Allergie ?

L'allergie est une **réponse anormale**, **inadaptée et exagérée du système immunitaire** suite à **des contacts répétés** avec des substances reconnues comme étrangères à l'organisme : **les allergènes.**

Épidémiologie et étiologie

- **Problème de Santé Publique : 4ème rang des maladies chroniques (OMS)**
- 20 % de la population mondiale

EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations). www.efanet.org/food-allergies/ Dernière consultation le 17 juin 2013.

Épidémiologie et étiologie

- Etiologie multifactorielle, **trois facteurs semblent cependant jouer un rôle important :**
  - **La Prédisposition génétique**
    - Risque **5 et 15%** si parents ne sont pas allergiques
    - **20-40%** si l'un des deux parents est allergique
    - **60 à 80%** si les deux parents sont allergiques.

Épidémiologie et étiologie

- **L'Exposition aux allergènes**
  - Une exposition précoce à des allergènes potentiels semble être associée à un risque plus élevé d'être allergique

- **L'Exposition aux adjuvants / virus et bactéries**
  - Rôle des adjuvants reste une énigme
    - rôle facilitant de la pollution atmosphérique **(ozone, suie de diesel, fumée de cigarette, polluants atmosphériques…),**
    - Rôle protecteur des **infections virales, bactériennes** des voies respiratoires de la petite enfance et **environnement riche en allergène** (fermes,…)

Allergènes

- Acariens
- Arbres, herbes, pollens de graminées
- Aliments
- Médicaments
- Insectes et leurs venins
- Squames, épithéliums et protéines d'origine animale
- Moisissures
- Poussières
- Allergènes professionnels

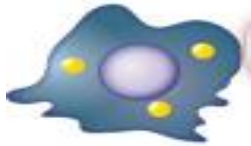
Mécanisme de la réaction allergique

Le phénomène biologique conduisant au développement d'une allergie se réalise à partir de 2 phases successives :

- **une phase initiale de « sensibilisation » asymptomatique** et
- **une 2e phase de « réaction allergique » symptomatique**

Phase de sensibilisation en 7 étapes: premier contact

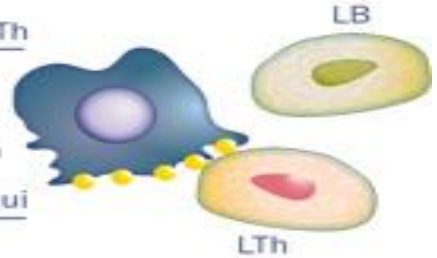
1 Entrée de l'allergène dans l'organisme

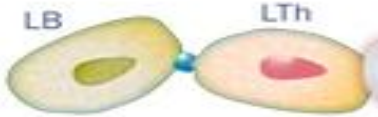


2 Captation puis phagocytose de l'allergène par le macrophage

3 Présentation de l'antigène spécifique à la surface du macrophage

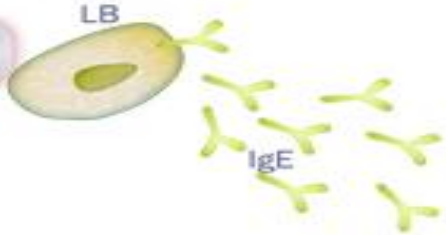
4
- Rapprochement d'un lymphocyte Th et du macrophage
- Reconnaissance et mémorisation de l'antigène par le lymphocyte Th
- Sécrétion de cytokines par le LTh qui stimule les lymphocyte B





5
- Transmission au Lymphocyte B des informations concernant l'allergène
- Différenciation des lymphocytes B en plasmocytes

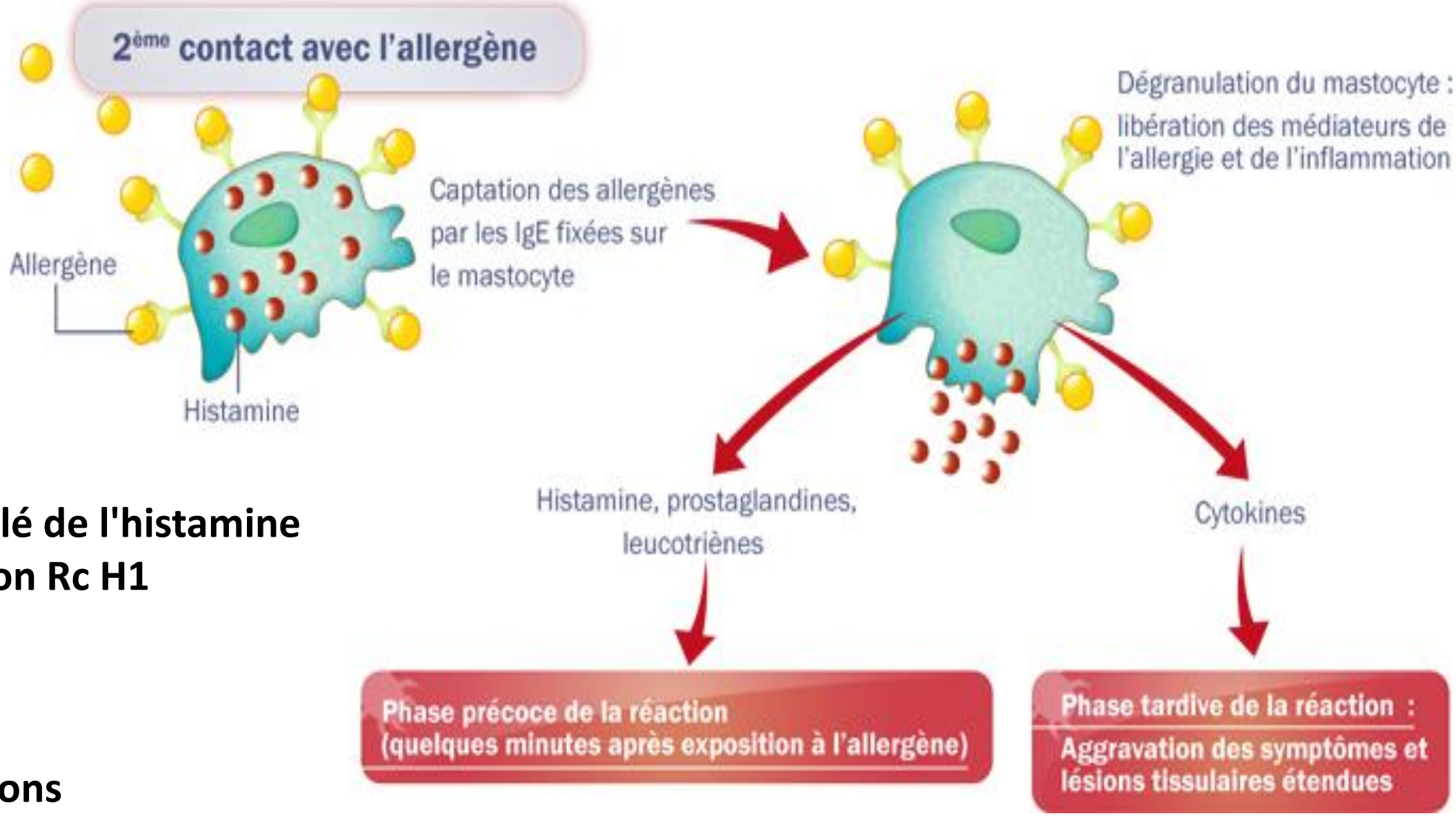
6 Production par les plasmocytes des anticorps spécifiques de l'antigène = Immunoglobulines E (IgE)
Passage des IgE dans le sang



7 Fixation des IgE à la surface des mastocytes siègeant au niveau de la peau et des muqueuses

Sensibilisation des mastocytes à une activation en cas de rencontre ultérieure avec le même allergène

Phase de sensibilisation latente et asymptomatique



Rôle clé de l'histamine
Fixation Rc H1
Nez
Peau
Yeux
Poumons

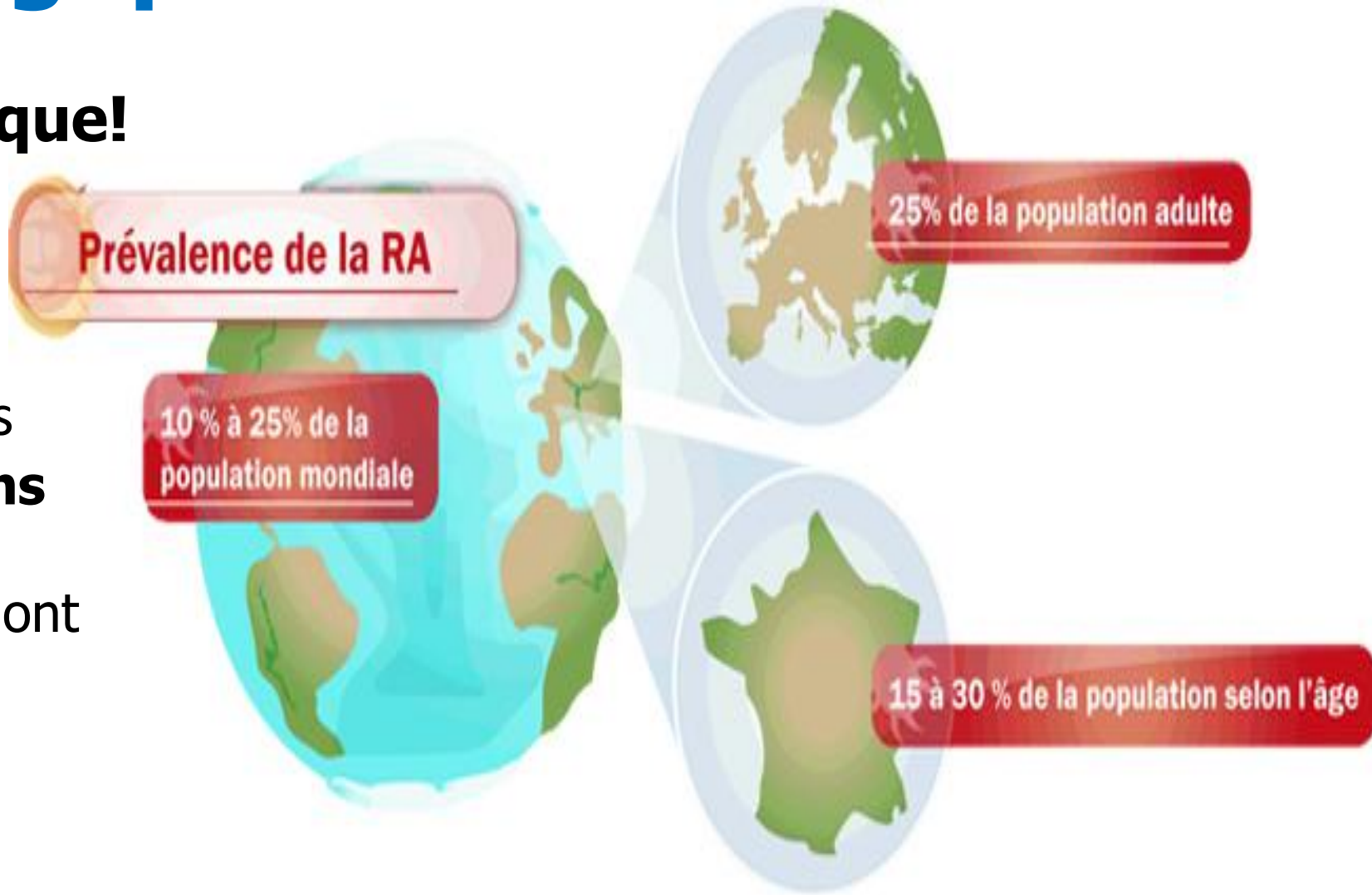
Quelques entités cliniques

Rhinite allergique

Véritable boom allergique!

Prévalence

- 7% chez les enfants
- 15% chez les adolescents
- **40 %** des cas **avant 6 ans**
- **58 %** des enfants et adolescents asthmatiques ont une RA



Rhinite allergique

Symptomatologie

Triade symptomatique de la RA

- **Rhinorrhée claire**
- **Obstruction nasale**
- **Eternuements et prurit nasal**

En faveur d'une cause allergique

- La notion de terrain atopique familial
- L'existence d'autres signes d'atopie (eczéma, asthme)
- Le parallélisme avec le lieu et le contact
- La rhinorrhée claire
- Les tics de reniflement ou de friction du nez
- L'absence d'amélioration après adénoïdectomie
- La persistance après l'âge de 4 ou 5 ans

Classification

La recommandation **ARIA 2008** *(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma)* propose une classification chronologique basée sur la durée des symptômes de la RA:

RA intermittente *versus* **RA persistante**

Classification

Intermittente

- **Symptômes**
  - ≤ 4 jours/semaines
  - **Ou** ≤ 4 semaines

Persistante

- **Symptômes**
  - >4 jours/semaines
  - **Et** > 4 semaines consécutives

Légère

- Sommeil normal
- Activités sociales/sportives et loisirs normaux
- Activités scolaires et professionnelles normales
- Symptômes peu gênants

Modérée à Sévère

- Sommeil perturbé
- Activités sociales/sportives et loisirs perturbés
- Activités scolaires et professionnelles perturbées
- Symptômes gênants

URTICAIRE

15 à 20 % de la population fait au moins une poussée aiguë au cours de sa vie

Papules œdémateuses

- fugaces et mobiles,
- entourées par un érythème,
- **une sensation de démangeaison (prurit et parfois sensation de brûlures),**
- taille variable.

Aigue ou chronique

(> 6 semaines)

ALLERGIE OCULAIRE

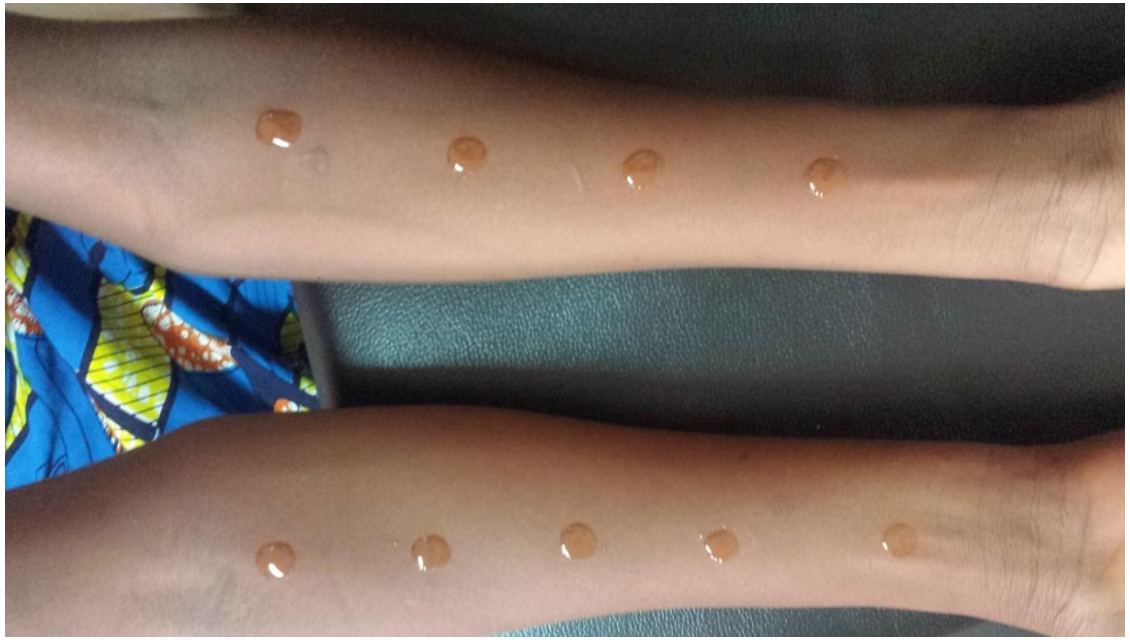
Les affections ophtalmiques d'origine allergique ont une prévalence de l'ordre de 25 % de la population générale

Symptomatologie est habituellement **bilatérale** avec **prurit**, **brûlures**, **sensation de grains de sable** et **hyperhémie conjonctivale,** des larmoiements, photophobie,

Chez l'enfant en milieu Tropical: souvent conjonctivite chronique allergique ou **LCET (limbo-conjonctivite endémique des tropiques)**

Nouveautés diagnostiques

- **Approche personnalisée fondée sur l'histoire clinique+++**
- **Tests cutanés dès 6 mois + IgE spécifiques**
- **Biologie moléculaire allergologique (CRD)**
  - **Component Resolved Diagnosis (CRD)**, ou **diagnostic moléculaire des allergies : révolution silencieuse en allergologie pédiatrique**, en permettant une **approche de précision**, plus sûre, plus ciblée
- **Applications d'auto-surveillance et tests à domicile**



Tests cutanés allergologiques

Quelle approche thérapeutique?

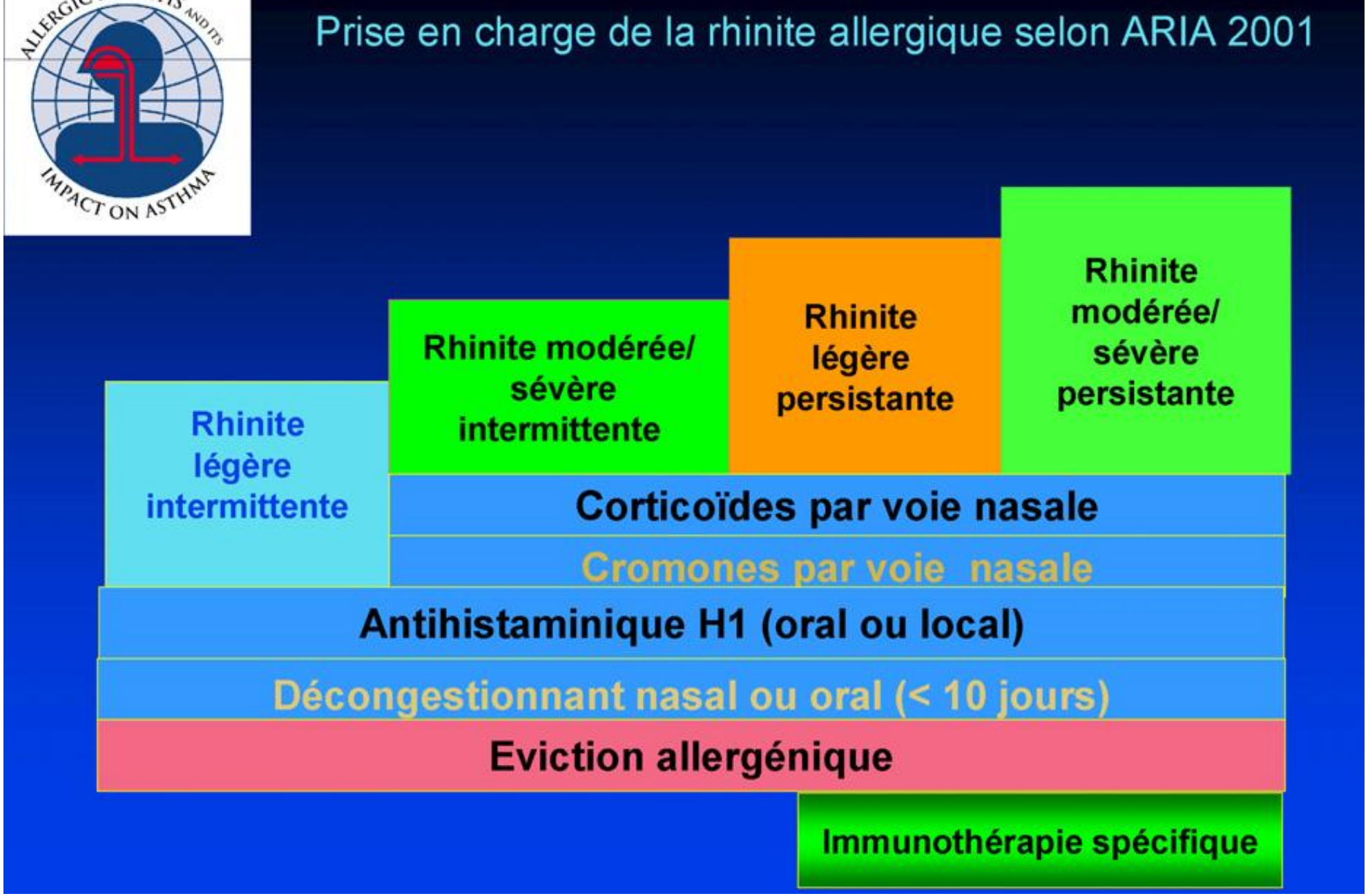
Antihistaminiques de 2ème génération

- Non sédatifs, bien tolérés, sans effet anticholinergique
- Formulations pédiatriques adaptées dès 6 mois
- Usage chronique sécurisé (rhinite, urticaire)

Quelle approche thérapeutique?

Autres innovations thérapeutiques

- Immunothérapie sublinguale dès 5 ans (rhinites, asthme)
- Biothérapies : Omalizumab (anti-IgE) en cas d’échec
- Pas d'antihistaminiques systématiques en prévention alimentaire
- Stratégie raisonnée et individualisée



Recommandations pour le traitement de la rhinite allergique en fonction du stade de sévérité et de son caractère intermittent ou persistant (Bousquet et al.)

Éducation et accompagnement

- **Informer sur les signes d’alerte : anaphylaxie, urticaire sévère…**
- **Formation à l’utilisation de l’adrénaline auto-injectable**
- **Trousse d’urgence personnalisée**
- **Approche pluridisciplinaire : médecin, nutritionniste, psychologue**

Messages clés et perspectives

- Antihistaminiques de 2eme génération : pilier du traitement
- Diagnostic précis = traitement ciblé = meilleure qualité de vie
- Rôle central des familles dans la gestion quotidienne
- Vers plus de biothérapies et d’outils numériques

Conclusion

Il faut savoir se battre tout seul pour mieux survivre?!

Merci de m'avoir écouter